

LAS ENFERMEDADES MENTALES Y LOS ASILOS DE ALIENADOS

INTRODUCCIÓN GENERAL — TEXTO ÍNTEGRO Y DEFINITIVO · Jean-Pierre Falret (1854 / 2002)

Traducción castellana oficial: Lic. Nora Carbone y Dr. Gastón Piazzese · Editorial De la Campana (La Plata, 2002)

Título original: *Des maladies mentales et des asiles d'aliénés* (París, Baillière, 1854)

Asignación académica: Clase 2 — Historia y paradigmas de la psiquiatría (Psicopatología I · UFLO Online 2026)

INTRODUCCIÓN

Dado que en aquella época ya tan lejana en la que apareció nuestra obra sobre la hipocondría y el suicidio¹ no tuvimos la suerte de publicar un tratado completo sobre las enfermedades mentales tal como lo habíamos pensado en el inicio de nuestra carrera, reunimos hoy, en un solo volumen, los trabajos que hemos publicado en diversos momentos y en diferentes libros. Nos pareció que la reimpresión de estos informes dispersos nos brindaría una ocasión natural de hacer conocer, como una introducción, nuestras opiniones sobre las enfermedades mentales.

Hemos pensado que esta exposición general constituiría el mejor camino para establecer una verdadera unidad de doctrina en medio de esos diferentes trabajos que no tienen entre sí otro lazo en común. Tal es, entonces, el objetivo que nos proponemos en esta introducción.

En una primera parte, indicaremos las fases que hemos recorrido en nuestro desarrollo científico desde el comienzo de nuestros estudios hasta la actualidad. En la segunda parte de esta introducción, nos dedicaremos a la exposición dogmática de nuestras opiniones principales sobre las diferentes ramas de la patología mental.

El movimiento de las ideas producido en la medicina mental hacia el final del último siglo ha tenido una doble característica: ha sido a la vez filantrópico y científico, de modo tal que, en la apreciación de los progresos realizados en nuestra especialidad a partir de aquella época, resulta imposible separar estos dos aspectos de la evolución de la ciencia.

Cuando Pinel estuvo a cargo de la división de los alienados de Bicêtre, dirigió su atención hacia el estudio y tratamiento de aquellos enfermos hasta ese momento tan descuidados. Al comienzo, el costado filantrópico de su misión lo absorbió por entero. Su corazón generoso se conmovió ante las numerosas miserias que por entonces soportaban los alienados. Rechazados por una sociedad que los consideraba un objeto de repulsión y de espanto; confundidos en las prisiones con los infractores de la ley o relegados en las partes más abandonadas de nuestros hospicios en medio de las condiciones higiénicas más detestables; librados a la cruel incuria de los guardianes sin control o expuestos, a ciertas horas, a la bárbara e indiscreta curiosidad del público; encerrados en calabozos ruines y húmedos, privados de aire y luz, acostados sobre paja, encadenados, sin vestimentas y sin ningún tipo de cuidados, estos desdichados enfermos vivían en el más completo abandono, y su agitación se transformaba entonces en verdadero furor. Semejante espectáculo, por entonces general tanto en Francia como en toda Europa, era perfecto para tocar el corazón de un médico filántropo como Pinel, en el momento en que éste penetró por primera vez en los habitáculos infectos y malsanos de los alienados de Bicêtre para quitar las cadenas de esos desafortunados y hacerlos pasar poco a poco del régimen de la pena más cruel al de una relativa libertad cada vez mayor y proporcionada a las exigencias de su estado.

Pero en ese generoso impulso de su corazón del que nació la era de renovación de los cuidados brindados a los enfermos en toda Europa, Pinel no se dejó llevar solamente por la tendencia natural de sus sentimientos personales; fue, sobre todo, el representante de las ideas y de los sentimientos de su siglo. Se transformó en uno de los instrumentos de la reforma social, producto de la filosofía del siglo XVIII, introducida tan violentamente por la revolución francesa en todas las clases sociales. Los derechos humanos habían sido ignorados; la dignidad del hombre, pisoteada en todos los grados de la escala social, fue rehabilitada por Pinel en la persona de los alienados. Confundidos hasta entonces con criminales, transformados en malditos ante los ojos de todos, fueron elevados por él a la dignidad de enfermos. Esta transformación en las ideas y en los prejuicios del público y de los médicos, cuyo puntapié inicial fue dado por Pinel en 1792, no pudo cumplirse en un solo día. Hizo falta la ayuda del tiempo y de varias generaciones para completarla. Todavía hoy asistimos a los últimos esfuerzos de ese gigantesco trabajo,

que tantas luchas ha exigido antes de culminar en los favorables resultados de los que felizmente somos testigos en la actualidad.

Sería imposible hacer verdadera justicia con los esfuerzos de nuestros ilustres maestros Pinel y Esquirol por mejorar la suerte de los alienados y por realizar las mejoras que han sido el fruto de su poderoso impulso. Pero debe señalarse que, aunque nuestros maestros dedicaran la mayor parte de su actividad a esa obra tan meritoria que bastó para volver célebres sus nombres, no descuidaban, sin embargo, el costado científico de su misión. Al mismo tiempo que satisfacían las necesidades tan imperiosas de la humanidad sufriente, hacían avanzar la ciencia. Herederos de las tradiciones de sus antecesores, continuadores de las doctrinas de sus ancestros, extrajeron de los médicos de la antigüedad (Hipócrates, Galeno, Paracelso, Areteo y Caelius Aurelianus) las bases de sus divisiones científicas². La manía y la melancolía, el delirio parcial y el delirio general admitidos desde la antigüedad, continuaron siendo, para Pinel y para Esquirol, el fundamento principal de sus descripciones y de sus clasificaciones.

Para apreciar sus doctrinas, debe agregarse a lo anterior otro elemento, al cual no se le ha dado quizá la suficiente importancia. Es la influencia de la filosofía reinante en la época en que Pinel publicó sus primeras obras. En aquel entonces, la doctrina sensualista de Locke y de Condillac dominaba como amo casi absoluto en las escuelas filosóficas y, así como alcanzó a todos los períodos de la historia de la medicina, fue también introducida por Pinel en la patología mental. Ella incidió poderosamente sobre su teoría y sobre su práctica imprimiendo, en sus escritos y en los de sus sucesores, el sello predominante de la psicología. Sello que, a pesar de las transformaciones sobrevenidas en nuestra especialidad a partir de comienzos de este siglo, todavía se encuentra en la mayor parte de las obras sobre las enfermedades mentales publicadas actualmente. Esquirol mismo, a pesar de su tacto práctico y de su fina observación, ha cedido, como lo han hecho otros alumnos de Pinel, ante esta tendencia general, tal como se evidencia en casi todos sus escritos y, sobre todo, en su tesis inaugural, publicada en 1805³.

El poderoso impulso impreso en Francia por Pinel y continuado por Esquirol y sus sucesores, tuvo rápida repercusión en los principales lugares de Europa. Mientras Chiarugi en Italia⁴, Daquin en Chambéry⁵, Samuel Tuke en Inglaterra⁶, preludiaban en sus respectivas patrias una reforma semejante a la cumplida por Pinel en Francia, Langermann⁷, Reil⁸ y Hayner⁹ comenzaban en Alemania un movimiento científico análogo. En ese país, sobre todo, dos escuelas rivales no tardaron en enfrentarse: la escuela psicológica y la escuela somática. Numerosas obras publicadas desde el comienzo de este siglo contienen la exposición de las luchas y de las discusiones de los partidarios de esas dos doctrinas, que han dividido durante largos años la opinión de los médicos alemanes. Como representantes principales de la escuela psicológica citaremos a Langermann, Reil, Heinroth¹⁰, Ideler¹¹ y, entre los fundadores de la escuela somática, a Nasse¹², Jacobi¹³ y todos sus alumnos, principalmente Zeller¹⁴, Roller¹⁵, Flemming¹⁶, Jessen¹⁷, Griesinger¹⁸ y la mayoría de los médicos actuales, pues la posición somática es hoy dominante en Alemania.

PARTE PRIMERA: EVOLUCIÓN DEL MÉTODO Y DE LA DOCTRINA

I. Primera fase: La anatomía patológica y la doctrina cerebrista

Alumnos de Pinel y de Esquirol en el hospicio de la Salpêtrière, hemos comenzado el estudio de la alienación mental bajo la égida de estos maestros ilustres. En la época en que seguíamos sus lecciones, una tendencia general dominaba la medicina contemporánea e incidía naturalmente sobre la patología mental. Los jóvenes médicos que estudiaban entonces las enfermedades mentales dirigían su atención preferentemente hacia las lesiones del cerebro y de las membranas encontradas en la autopsia de los alienados.

Contrariamente a las doctrinas de nuestros maestros, nosotros cedíamos, como tantos otros, ante esa dirección anatómica de la ciencia, considerada en aquella época como la verdadera base de la medicina. Fijábamos nuestra atención sobre ciertos temas tales como el suicidio, la hipocondría, la manía sin delirio; pero como doctrina general, llegábamos rápidamente a convencernos de que la anatomía patológica bastaba para dar la razón primera de los fenómenos observados en los alienados; de que los progresos de la ciencia debían residir en su estudio, proseguido con perseverancia.

Todos los artículos que publicamos entonces en diferentes libros llevan tal impronta dominante. Ésta se vuelve a encontrar en nuestro *Traité de l'hypochondrie et du suicide*. Nuestra convicción respecto de esa idea fue llevada tan lejos, que pensamos concebir un trabajo titulado: «Inducciones a extraer de las autopsias de los cuerpos de los alienados para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales».

Otra tendencia igualmente general reinaba en la medicina mental de aquella época. Consistía en ubicar solamente en el cerebro la sede de todas las formas y de todas las variedades de la locura y en negar casi completamente la influencia de otros órganos en la producción de dicha enfermedad. Esta idea, introducida en la patología sobre todo por Gall, había encontrado numerosos adeptos, y la mayor parte de los médicos que se ocupaban del estudio de las enfermedades cerebrales, como Rostan, Calmeil, Bayle, Georget, Foville, etc., compartían tal pensamiento dominante. Sólo admitían muy raramente, o no lo hacían nunca, la existencia de la locura simpática. Ésta fue también nuestra opinión, así como la de nuestro colega y amigo Félix Voisin, quien publicó una obra que se hacía eco de idénticas ideas generales¹⁹. En aquel momento éramos a la vez anatomistas y cerebristas. Creíamos firmemente que, en todos los casos sin excepción, se encontraban en el cerebro de los alienados o en sus membranas, lesiones apreciables lo suficientemente marcadas y constantes como para dar cuenta de un modo satisfactorio de los trastornos tan variados de las facultades intelectuales y afectivas de la locura.

En 1828 y 1829, nos dedicamos a realizar numerosos trabajos estadísticos sobre los alienados, los suicidios y las muertes súbitas, trabajos que nos valieron un premio de estadística en el Instituto durante dos años consecutivos²⁰.

II. Segunda fase: El método psicológico y la crítica a la psicología patológica abstracta

Luego de haber buscado durante mucho tiempo el fundamento de la patología mental en las alteraciones del cerebro de los alienados, llegamos poco a poco a comprender que por más importantes que fueran esas lesiones, no podían bastar para explicar científicamente la enorme diversidad y los matices tan sutiles de los fenómenos psíquicos de los alienados. A partir de entonces, comenzamos a buscar en la psicología los medios para suplir la insuficiencia de la anatomía patológica.

Estudiamos con perseverancia los numerosos escritos de los psicólogos, sobre todo los de la Escuela escocesa. Intentamos compenetrarnos con sus doctrinas y redactamos una psicología para nuestro uso, destinada a esclarecer el conocimiento de las lesiones psíquicas constatadas en las diversas formas de las enfermedades mentales. Este trabajo, al que ya se habían dedicado los médicos-psicólogos de la escuela alemana y que todavía hoy siguen realizando con éxito especialistas eminentes de Francia como Parchappe²¹, Félix Voisin²², Renaudin²³, Delasiauve²⁴, Billod²⁵, nos parecía en aquel momento el mejor medio para arribar a una teoría racional de la locura y para sistematizar científicamente las diversas partes de la medicina mental.

No retrocedimos frente a ningún obstáculo para obtener aquel resultado que nos parecía tan deseable, y proseguimos la búsqueda minuciosa, en los alienados, de las lesiones de la memoria, de la asociación de ideas, del juicio e incluso de la abstracción; en una palabra, debíamos encontrar, en el estado de enfermedad, las lesiones aisladas o complejas de todas las facultades reconocidas por los psicólogos en el estado normal. Durante quince años aproximadamente, perseveramos en esa línea científica. Estábamos persuadidos de que, así como en la patología ordinaria la fisiología debía echar luz sobre la medicina, correspondía a la psicología normal hacer lo propio con la medicina mental.

Pero cuanto más avanzábamos en nuestros estudios en esa dirección, en apariencia tan racional, más nos convencíamos de que ese punto de vista teórico preconcebido estaba condenado por la práctica y se contraponía al verdadero progreso de la ciencia. En efecto, ¿qué se hace cuando se estudian, según el método psicológico, las manifestaciones tan complejas de la inteligencia y de los sentimientos en los alienados? Se toman prestadas las divisiones y subdivisiones de las facultades realizadas por los psicólogos para hacer de ellas el preámbulo obligado de la sintomatología de las enfermedades mentales. Se hace de antemano una clasificación metódica de esas facultades y, a continuación, se buscan en los alienados las alteraciones correspondientes a cada una de esas divisiones o a los diferentes tiempos de un mismo fenómeno.

Uno se consagra así a un trabajo totalmente artificial, que consiste en encontrar una lesión de una facultad para ponerla en paralelo con cada uno de los actos de dicha facultad en estado normal. Ahora bien, como esas facultades sólo pueden sufrir tres

órdenes de alteraciones; como, según las leyes que las rigen, sólo pueden estar exaltadas, debilitadas o pervertidas, todo trabajo de clasificación de los fenómenos psíquicos según el método psicológico puede descubrir, en los alienados en general o en cada uno en particular, nada más que uno de esos tres modos de trastorno de las facultades admitidas en el estado normal. Pero, ¿cuál es el grado o la variedad especial de ese desorden intelectual o sentimental? ¿Cuál es el lazo entre estos diversos trastornos? ¡He aquí lo que importaría conocer para la práctica de la medicina mental y lo que el método psicológico no nos permite aprehender!

Este procedimiento de clasificación que, al principio, parece seductor para el estudio de los síntomas psíquicos, tampoco provee los elementos de una buena semiología de las enfermedades mentales. En lugar de hacer una distribución útil de los síntomas tal como los presenta la enfermedad, uno se limita a un trabajo de abstracción que puede satisfacer a la mente como una hazaña ingeniosa, pero que no tiene ningún resultado práctico. Frecuentemente, se toman en cuenta hechos insignificantes para completar un casillero vacío en el cuadro sinóptico, descuidando, precisamente, aquellos hechos más importantes que pueden tener valor de signos diagnósticos y pronósticos de las enfermedades. Uno se parece a los químicos modernos que, habiendo reconocido la existencia de series de elementos análogos, buscan descubrir los elementos todavía desconocidos de la serie para colmar la laguna, con la diferencia capital de que por ese procedimiento teórico, los químicos encuentran nuevos cuerpos que tienen realidad en la naturaleza, mientras que los psicólogos dedicados al mismo trabajo sólo arriban a abstracciones sin utilidad práctica. Actuar de ese modo es hacer psicología patológica, no hacer medicina. Por una ruptura violenta, se escinden todos los fenómenos que habitualmente se encuentran reunidos en la naturaleza. Se arranca un hecho psíquico de todo su entorno para hacerlo figurar en una misma categoría junto con otros hechos que están naturalmente separados de él. Entonces, se separa lo que está reunido y se reúne lo que está separado. Las relaciones naturales entre las cosas se rompen. Por un único punto de contacto, se reúnen hechos que difieren en todos los demás puntos de vista. Se aplica un sistema y no el método natural.

Se actúa como si el botánico estudiara aisladamente el color, la forma o el tamaño de las plantas, en lugar de buscar conocer los rasgos generales que las distinguen de otras plantas vecinas. Se procede como si el químico, queriendo aprehender la química orgánica, la redujera al estudio de los cuatro elementos fundamentales (carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno), en lugar de investigar las características de los compuestos transformados en unidades tales como el azúcar, el alcohol o el éter, únicos conocimientos que pueden presentar utilidad para la práctica. Pero el método psicológico aplicado al estudio de las alienaciones mentales no sólo es malo cuando se trata de hacer semiología, sino que además se torna fecundo en consecuencias nefastas cuando se lo quiere aplicar a otras ramas de la patología mental, como la etiología, la nosología e incluso la terapéutica; cuando, por ejemplo, se quiere explicar el modo de producción de la locura o de las ideas delirantes por la lesión de ciertas facultades como la atención o la voluntad; cuando se quiere clasificar las diversas especies o variedades de la locura por un procedimiento psicológico; finalmente, cuando se pretende curar las ideas o los sentimientos de los alienados por medios psicológicos. Entonces, ya no sólo se hace psicología patológica, sino que se tiene la pretensión de hacer medicina.

III. Tercera fase: El período clínico, la dualidad humana y la génesis de los delirios

Es ésta, en definitiva, la conclusión a la que hemos llegado y que representa la tercera fase de nuestra vida científica, a la que damos el nombre de **fase clínica**. Hemos comprendido que cada ciencia tenía sus exigencias particulares; que no debían tomar prestadas las leyes y procedimientos de ciencias vecinas; que si bien podían servirse de apoyo las unas a las otras, cada una debía extraer su método y sus leyes de sí misma. Entonces, es en la patología mental misma, es en la observación clínica de los alienados donde debemos buscar los principios de nuestra ciencia.

Para comprender la génesis de los delirios y de los trastornos anímicos, hemos formulado la teoría de la **dualidad humana**. Para nosotros, la función cerebral o la manifestación de la vida psíquica reposa sobre el antagonismo armónico de dos elementos fundamentales: por una parte, el elemento instintivo, afectivo, involuntario y automático; por otra parte, el elemento intelectual, reflexivo, voluntario y moderador. Esta teoría de la dualidad humana, que consideramos verdadera en el estado normal, puede ser rastreada fielmente en el estado de enfermedad. Ella nos permite concebir, de un modo diferente al de los psicólogos puros, la patogenia de los trastornos mentales.

En la alienación mental, lo que se encuentra primitivamente alterado no es la inteligencia fría ni el juicio abstracto, sino la **afectividad moral, las inclinaciones y los sentimientos**. Es sobre ese fondo mórbido primordial, sobre esa modificación afectiva profunda y dolorosa, donde germinan y se desarrollan secundariamente las ideas delirantes y las concepciones patológicas. El delirio no es la causa de la locura, sino su expresión y su consecuencia intelectualizada. Esta alteración primitiva de los sentimientos y de las inclinaciones merece toda la atención por parte de los clínicos, pues constituye el verdadero punto de partida de la afección y la clave del diagnóstico precoz.

IV. Cuarta fase: La observación diacrónica y el descubrimiento de la Locura Circular

El reconocimiento de la insuficiencia de las clasificaciones clásicas basadas en el contenido momentáneo de los síntomas nos llevó a formular nuestra máxima metodológica más trascendente: **la observación continuada de la marcha natural de las enfermedades**. En lugar de fijar la mirada en el estado presente del enfermo en un período arbitrario, es indispensable seguir la marcha de la enfermedad a través de todas las fases que atraviesa, registrando sus oscilaciones, sus períodos de remisión y sus alternativas de transformación.

Fue mediante este método diacrónico como logramos aislar y describir la **Locura Circular** (o *locura de doble forma*), afección caracterizada por la sucesión regular y alternante de un período de excitación maníaca y de un período de depresión melancólica, separados o no por un intervalo de lucidez completa. Lo que durante siglos había sido dividido erróneamente en dos enfermedades antagónicas e independientes —la manía y la melancolía— se reveló ante la observación longitudinal como una única entidad patológica dotada de una marcha específica y característica.

PARTE SEGUNDA: PRINCIPIOS DIRECTRICES DE LA CIENCIA PSICOPATOLÓGICA Y DOCTRINA ASILAR

1. Definición y naturaleza somática: La alienación mental es una verdadera afección cerebral caracterizada por desórdenes intelectuales, afectivos y del comportamiento que destruyen la libertad moral del individuo. El alma en su esencia espiritual no enferma ni se corrompe: es el sustrato orgánico cerebral de su manifestación el que padece la lesión y perturba el ejercicio de las funciones psíquicas.

2. Etiología: Las causas actúan por acumulación. Distinguimos cuidadosamente entre las *causas predisponentes* (donde la herencia ejerce una influencia soberana y determinante) y las *causas desencadenantes* o accidentales (emociones morales vivas, reveses sociales, pasiones exaltadas y trastornos fisiológicos).

3. Nosología y Clasificación Natural: Rechazamos las clasificaciones sintomáticas artificiales que dividen las psicosis según el objeto del delirio (erotomanía, demonomanía, megalomanía). La nosología debe basarse en la marcha y evolución natural:

- *Enfermedades curables de marcha aguda o subaguda:* Manías y melancolías agudas francas.
- *Enfermedades crónicas e incurables:* Afecciones que evolucionan de modo continuo hacia el debilitamiento o la demencia terminal.
- *Enfermedades periódicas y circulares:* Afecciones caracterizadas por accesos repetidos o por la alternancia cíclica de estados opuestos.

4. Doctrina del Asilo y Tratamiento Moral: El aislamiento del enfermo respecto de su familia y de su medio habitual constituye la base indispensable de la terapéutica. El asilo de alienados debe concebirse como un instrumento médico de curación y no como un mero lugar de confinamiento. La combinación del tratamiento moral (disciplina benévola, trabajo regulado, ocupaciones intelectuales, régimen asilar) con los medios médicos físicos proporciona los únicos auxilios eficaces para la recuperación de los alienados.

5. Anatomía Patológica y Futuro de la Ciencia: Reconocemos la necesidad de continuar investigando las alteraciones orgánicas del sistema nervioso, pero advirtiéndole contra las ilusiones del mecanicismo grosero. Solo una psiquiatría fundamentada

en la observación clínica diacrónica y libre de dogmatismos psicológicos o anatómicos abstractos podrá cumplir plenamente su misión médica y humana.

NOTAS AL PIE Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ORIGINALES

1. J.-P. Falret, *De l'hypochondrie et du suicide*, París, 1822.
2. Ulysse Trélat, *Recherches historiques sur la folie*, París, 1839.
3. J.-E.-D. Esquirol, *Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale*, Thèse de Paris, 1805.
4. V. Chiarugi, *Della pazzia in genere e in specie*, Florencia, 1793.
5. J. Daquin, *La philosophie de la folie*, Chambéry, 1792.
6. Samuel Tuke, *Description of the Retreat, an institution near York for insane persons of the Society of Friends*, York, 1813.
7. J. G. Langermann, *Dissertatio de methodo curandi cognoscendique animi morbos stabilienda*, Jena, 1797.
8. J. C. Reil, *Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen*, Halle, 1803.
9. J. G. Hayner, *Aufforderung an Regierungen, etc., in der Behandlung der Irren*, Leipzig, 1817.
10. J. C. A. Heinroth, *Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens*, Leipzig, 1818.
11. K. W. Ideler, *Grundriss der Seelenheilkunde*, Berlín, 1835.
12. C. F. Nasse, *Zeitschrift für psychische Aerzte*, Leipzig, 1818.
13. M. Jacobi, *Die Hauptformen der Seelenstörungen*, Leipzig, 1844.
14. E. A. Zeller, *Bericht über die Wirksamkeit der Heilanstalt Winnenthal*, Stuttgart, 1838.
15. C. F. W. Roller, *Die Irrenanstalt nach allen ihren Beziehungen*, Karlsruhe, 1831.
16. C. F. Flemming, *Pathologie und Therapie der Psychozen*, Berlín, 1859.
17. P. Jessen, *Allgemeine Encyclopaedie*, Berlín, 1839.
18. W. Griesinger, *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten*, Stuttgart, 1845; 2.^a ed., 1861.
19. Félix Voisin, *Des causes morales et physiques des maladies mentales*, París, 1826.
20. Informe de Antoine Serres sobre los trabajos estadísticos de Falret, *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, París, 1829.
21. Max Parchappe, *Symptomatologie de la folie*, Ann. médico-psych., 1851.
22. Félix Voisin, *Analyse de l'entendement humain*, París, 1857.
23. E. Renaudin, *Études médico-psychologiques sur l'aliénation mentale*, Nancy, 1857.
24. L. Delasiauve, *Journal de médecine mentale*, París, 1861.
25. E. Billod, *Des maladies de la volonté*, Ann. médico-psych., 1847.
26. J. Moreau de Tours, *De la folie au point de vue pathologique*, Ann. médico-psych., 1855.
27. J. Guislain, *Traité des phrénopathies*, Bruselas, 1833.